



**FACULTAD DE OBSTETRICIA Y ENFERMERÍA
“HILDA ZORAIDA BACA NEGLIA “
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

PLAN DE TESIS

**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN
MADRES EN EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
BREÑA 2025**

PARA OPTAR

EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

PRESENTADO POR:

ANA MARIA CRUZ VALDIVIA

ASESORA:

MG. JANET GUEVARA CASAS

LIMA, PERÚ

2025

ÍNDICE

	Págs.
Portada	i
Índice	ii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1 Descripción de la situación problemática	1
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivos de la investigación	6
1.4 Justificación de la investigación	7
1.4.1 Importancia de la investigación	7
1.4.2 Viabilidad del estudio	9
1.5 Limitaciones de estudio	9
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	9
2.1 Antecedentes de la investigación	9
2.2 Bases teóricas	12
2.3 Definición de términos básicos	25
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	27
3.2 Variables y definición operacional	27
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA	28
4.3 Técnica de recolección de datos	28
4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	29
4.5 Aspectos éticos	29
CRONOGRAMA	31
PRESUPUESTO	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXOS	41

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la situación problemática

En el devenir de la humanidad, un elemento esencial para la supervivencia ha sido la leche materna, ya que es el mejor alimento para los recién nacidos. Conocida también como leche natural, la leche materna tiene una amplia evidencia científica sobre sus beneficios para la alimentación de los recién nacidos y sobre todo los primeros dos años de vida, pero de manera exclusiva los seis primeros meses de vida. Es necesario recalcar su importancia entre las madres, que por una serie de cambios sociales, culturales y tecnológicos van dejando esa práctica, que puede llegar a perjudicar la salud de su hijo¹.

La leche materna por sus nutrientes tiene muchas ventajas tanto para la madre como para su hijo, es necesario que conozcan estas ventajas, mantenerlas informadas por sus beneficios nutricionales, fisiológicos, psicológicos y sociales, fomenta el apego y fortalece los lazos humanos que tendrán repercusiones en el futuro. Los organismos y asociaciones internacionales vienen difundiendo la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento ya que es el alimento ideal para proporcionar un crecimiento y desarrollo sano para el lactante, provee de anticuerpos que los protege de enfermedades de la infancia como diarrea y neumonía consideradas a nivel mundial las principales causas de muerte infantil^{2,3}.

Beneficia a las madres pues reduce el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, les ayuda a recuperar el peso que tenían antes del embarazo de manera rápida, les ayuda a restablecer el metabolismo y evitar condiciones de obesidad. También en el sistema cardiovascular materno actuando sobre el nivel de lípidos, la presión arterial, la insulina y los niveles de glucosa³. Gerd et al.⁴ en su estudio demuestra que el desconocimiento provocaría el cese de la producción de leche y así como su abandono; desconocer la técnica de amamantamiento, el uso de chupones, la falta de apoyo, administración de leche de fórmula, el uso de tabaco, dolor en los pezones, y la creencia de no tener leche suficiente son considerados factores de riesgo.

La lactancia materna es el “patrón de oro” de la alimentación del recién nacido y contribuye al desarrollo pondo estatural, psico motor y psico social evitando el riesgo de morbilidad y de un innecesario costo económico y social. Así mismo, los riesgos de alimentar con sucedáneos se relacionan a que producen una peor adaptación gastrointestinal, recurrentes infecciones gastrointestinales incluso el síndrome de muerte súbita del lactante⁵.

También dificultades digestivas y alimenticias, riesgo de maloclusión o mordida abierta por el uso de biberones, peor desarrollo neurológico afectando a la inteligencia no verbal y al desarrollo cognitivo; obesidad, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, peor vínculo afectivo, riesgo de maltrato infantil. Para la madre hay riesgo a hemorragias postparto, peor involución uterina, pérdidas menstruales en los meses después del parto lo que les ocasiona riesgo a anemia y pérdida de hierro, incidencia de artritis reumatoide, riesgo de diabetes tipo II, riesgo de cáncer de mama y de cáncer epitelial de ovario⁵.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)⁶, 2022, refiere que a nivel mundial las cifras con respecto a la lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses se ha incrementado a partir del 2020 siendo de 43.8% en comparación de 37.1% de años anteriores. Los datos muestran que 84% de la cifra actual corresponde a países de ingresos bajos o medianos bajos; se espera que la cifra se incremente al 70% para el 2030. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)⁷, 2023, afirma que en zonas rurales del Perú equivale a 78.3%, y en zonas urbanas es de 69.3%.

A nivel mundial el porcentaje es de 48% al 2023 de niños que reciben lactancia materna antes de los 6 meses, cifra cercana a la meta del 50% para el 2025. Países en África, Asia, Europa y Oceanía han demostrado en documentos los incrementos en sus cifras con relación a años anteriores; en países como Kenia, Pakistán, Serbia, Sierra Leona y Vietnam han intensificado sus políticas de protección y soporte al amamantamiento⁸.

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)⁹, 2025, el Perú es uno de los países con mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva desde el 2019 con una tasa de 65.3%, seguido por Uruguay con 57.7% y Bolivia con 55.7%, siendo las tasas más bajas las de Republica Dominicana y Venezuela con 4.6% y 7.1% respectivamente. En América del Norte, 27% de los niños menores de 6 meses reciben LME y 55% de los niños en América Latina y el Caribe son amamantados en la primera hora de vida. Esta prevalencia se relaciona con el conocimiento que tiene la madre es por ello por lo que a mayor conocimiento la prevalencia aumentará.

El conocimiento es definido por Alavi y Leidner como la información que una persona posee en su mente, de forma personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables. Este conocimiento se convierte en una variable que se puede medir y determinar cuánto conocen las madres sobre los aspectos generales de la LM, la técnica de lactancia materna, así como la extracción y conservación de la leche materna^{10,11}.

En el Perú, García et al¹², 2024, realizaron el estudio sobre Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres de niños menores de seis meses que acuden a Control de Niño Sano en el Centro de Salud Mariano Melgar, Arequipa 2024. Encontraron que 62% de las madres muestran un nivel medio de conocimiento sobre lactancia materna, 23% tienen un nivel alto y 15% un nivel bajo.

Igualmente, en México, Tellez-Perez et al¹³, 2020, publicaron su estudio sobre Conocimiento sobre Lactancia Materna de mujeres puérperas que acuden al primer nivel de atención, sus hallazgos fueron que 69% (69) tuvieron un nivel de conocimiento medio, 14% (14) fue alto y 17% (17) bajo. Del mismo modo, en Ecuador, Carrasco et al.¹⁴, 2021, en su investigación sobre Nivel de Conocimientos sobre LME en madres de lactantes menores obtuvieron que 45.84% (22) tuvieron un nivel bajo, 33,33% (16) un nivel medio y 20.83% (10) un nivel alto.

Según cifras estadísticas de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)¹⁵ al 2024, el 65.9% de los menores de seis meses reciben lactancia

materna exclusiva y desde el año 2023 esta cifra se viene incrementando, hasta llegar a la meta nacional que es 70% al 2030. A nivel nacional, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)¹⁶ indica que las cifras muestran una alta prevalencia de la lactancia materna exclusiva en los departamentos de Junín, Huancavelica, Cajamarca y Ancash, seguidos por Apurímac, Ayacucho y Loreto. En cuanto a Lima y Callao mantienen cifras relativamente bajas con respecto al interior del país, siendo el Callao el que ha tenido una visible mejora con respecto a los últimos años.

El Ministerio de Salud del Perú (MINSA)^{17,18} en la Norma Técnica de Salud N° 214-2024 sobre Atención Integral de Salud Neonatal, tiene por objetivo reducir la morbilidad neonatal en nuestro país, menciona la importancia del contacto piel a piel a fin de fomentar el apego y el amamantamiento temprano, poniendo énfasis en promover y mantener la lactancia materna exclusiva a libre demanda desde las primeras horas de vida en alojamiento conjunto. Enfermería participa realizando actividades de información, orientación, educación y comunicación a la madre, promoviendo una lactancia materna exitosa.

Según la Teoría de Adopción del Rol maternal de Mercer¹⁹ la madre enfrenta una serie de factores tanto internos como externos que influyen en la adopción del rol. Algunas de ellas lo logran con éxito, pero la mayoría presenta dificultades que son necesarias identificar, sobre todo en la alimentación de su hijo por medio de la lactancia materna. Para ejercer el rol maternal adecuadamente requiere de aprendizaje, no solo basta con el instinto maternal que toda mujer posee cuando da a luz un hijo.

Es por ello que la enfermera cumple una función y un rol importantes como educadora y orientadora ya que imparte los conocimientos a la madre y la ayuda a identificar esos factores que obstaculizan la adopción de su rol, que incluye el proceso de la lactancia materna para que sea exitoso y beneficie tanto a la madre como a su hijo.²⁰

Durante el internado comunitario en el Centro de Salud de Breña en el servicio de Crecimiento y Desarrollo, se pudo constatar que muchas madres de bebés menores de seis meses carecen de información acerca de la trascendencia de la lactancia materna exclusiva, refirieron desconocer las técnicas de amamantamiento, el uso de fórmulas y de los biberones. Al indagar sobre su técnica de amamantamiento, muchas no la llevaban a cabo de manera adecuada porque no les habían explicado y dijeron que no tenían claros sus conocimientos fundamentales relacionados con la lactancia materna al respecto de la higiene y a la conservación de la leche.

Por lo mencionado anteriormente se formula la siguiente pregunta:

1.2 Formulación del problema

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres en el servicio de crecimiento y desarrollo del Establecimiento de Salud Breña 2025?

1.3 Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres en el servicio de crecimiento y desarrollo del establecimiento de salud Breña 2025

Objetivos Específicos:

- a) Identificar el nivel de conocimiento de lactancia materna según dimensión aspecto generales.
- b) Identificar el nivel de conocimientos según dimensión técnicas de amamantamiento.
- c) Identificar el nivel de conocimiento según la dimensión extracción manual de la leche

1.4 Justificación de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

El presente trabajo se considera importante desde el punto de vista Teórico, Legal, Práctico y Metodológico.

Teórico:

Se fundamenta en la teoría de los cuidados de Swanson, en la cual la enfermera mantiene una relación como educadora con la madre a fin de transmitirle todos los conocimientos que promuevan la adherencia a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de su hijo.

Legal:

Existe un marco legal estipulado por el ente rector en salud, ya que el Minsa emite las normas técnicas que enmarcan las funciones del personal de salud, así como el actuar de la enfermera en la atención en salud de la población.

En lo referente a la lactancia materna, las normas técnicas del Minsa utilizadas

son la NTS N° 214-2024 Atención integral de salud neonatal y NTS N° 137-2017 Control de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años. Así mismo, la Guía Técnica para la consejería en lactancia materna

Práctico:

La enfermera del primer nivel de atención es quien se encarga del control del niño en el servicio de crecimiento y desarrollo; el recién nacido recibe 4 controles a partir de su nacimiento hasta cumplir el primer mes de vida. Durante esta etapa y como parte de sus funciones la enfermera realiza actividades educativas y demostrativas a la madre con el fin de fomentar y mantener la lactancia materna del niño. Mediante el dialogo la madre puede expresar sus dudas e inquietudes con respecto a este proceso y la enfermera es quien reforzará los conocimientos de la madre.

Metodológico:

En los establecimientos del primer nivel de atención el personal de enfermería atiende las diversas estrategias para la atención de salud de la población, en el Servicio de Crecimiento y Desarrollo son atendidos todos los niños y niñas de 0 a 11 años, siguiendo los protocolos de atención según la edad. Los recién nacidos reciben cuatro controles a partir de las 48 horas de nacido siendo la atención cada 7 días hasta cumplir los 28 días, posteriormente se le atiende mensualmente hasta cumplir los 11 meses y 29 días de vida.

Durante esta etapa de vida la enfermera realiza las evaluaciones y controles respectivos verificando que la madre amamante de manera exclusiva a su hijo durante los primeros seis meses y luego continúe junto con la alimentación que recibirá el niño, de preferencia hasta que cumpla los dos años de edad para recibir lactancia materna o hasta cuando ella lo decida.

1.4.2 Viabilidad del estudio

El presente trabajo es viable pues se cuentan con los recursos necesarios tanto humanos, financieros, materiales y la disponibilidad de tiempo. Igualmente, se solicitará la autorización respectiva a las autoridades del Establecimiento de Salud una vez que el proyecto sea aprobado.

1.5 Limitaciones de estudio

Se podrían presentar limitaciones en cuanto al tiempo para iniciar la ejecución del presente trabajo ya que dependerá de los permisos oportunos que otorguen las autoridades respectivas. Así mismo, se espera que la mayoría de las madres deseen colaborar participando de la encuesta, caso contrario, se deberá tomar el tiempo necesario hasta contar con una muestra representativa que permitan estimar los resultados.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Internacionales:

Freire et al.²¹ en 2025 realizaron un estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre LME: perspectivas en gestantes y madres postparto. La metodología utilizada fue un estudio descriptivo, transversal con 105 mujeres gestantes y postparto en un centro de salud de Riobamba Ecuador. Sus resultados fueron que 66.7% (70) tenían un alto nivel de conocimientos y actitudes favorables hacia la LM por otro lado, 19% (20) muestran bajos niveles en ambas variables.

Hernández et al.²² en Cuba, 2023 publicaron su estudio sobre Conocimientos de padres y madres sobre LME. La metodología fue descriptivo transversal con una muestra de 27 padres y 27 madres de lactantes. Sus resultados fueron que mostraron conocimientos altos 48.1% (13) madres y 40.7% (11) padres tuvieron conocimientos medios.

Salazar et al.²³ en Colombia, 2020 realizaron el estudio sobre Conocimiento sobre LME en primigestantes que asisten a control prenatal en Neiva, 2020. La metodología utilizada fue enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal. Los resultados muestran que el nivel de conocimientos fue regular en 63% (68), bueno en 10% (11) y malo en 27% (29).

Carrasco et al.²⁴ en Ecuador, 2021 efectuaron su estudio acerca de Nivel de conocimiento sobre LME en madres de lactantes menores ingresadas en el área de hospitalización materno infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 2021. La metodología de su estudio fue descriptivo y cuantitativo, la muestra estuvo constituida por 48 madres. Los resultados mostraron que 45.84% (22) mostraron un nivel bajo, 33.33% (16) un nivel medio y 20.83% (10) un nivel alto.

Romero et al.²⁵ en Ecuador, 2023, publicaron su estudio sobre Conocimientos sobre LM en madres de niños menores de 2 años de edad de la Universidad Técnica de Babahoyo. La metodología fue estudio observacional, descriptivo, cuantitativo, la muestra fue 247 mujeres. Los resultados fueron que 82.1% respondieron conocer lo que es el calostro, más de la mitad conoce los beneficios de la lactancia materna y 62% reconoce que no hay un tiempo ideal.

Nacionales:

Quispe²⁶ en 2022 publicó su investigación sobre Nivel de conocimientos y su relación con las prácticas de lactancia de las madres con niños menores de 06 meses de edad, centro de salud San Genaro-Chorrillos Lima, 2022. La metodología fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y transversal, se trabajó con una muestra de 106 sujetos. Sus resultados mostraron que 71% (75) tenían un conocimiento medio y con prácticas deficientes, 65% (69) con prácticas regulares.

Gutiérrez²⁷ en 2020 realizó una investigación sobre Conocimientos y Actitudes sobre LME en madres multíparas en el servicio de CRED del Hospital Nacional 2 de mayo. La metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo correlacional y diseño no experimental, la muestra fue de 74 madres multíparas. Sus resultados fueron que existe relación significativa entre ambas variables, 43.2% (32) poseen un nivel de conocimiento alto, 51.4% (38) muestran un nivel de conocimiento medio y 5.4% (4) tienen un nivel bajo.

Capulian et al.²⁸ en 2022 presentaron su estudio sobre Nivel de conocimiento y Actitud sobre LM en madres de niños menores de 3 años, Hospital Alberto

Sabogal Sologuren. Su metodología fue de tipo aplicada, diseño no experimental, descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 89 madres. Sus resultados muestran que 14.61% (13) tienen un nivel de conocimiento bajo, 59.55% (53) un nivel medio y 25.84% (23) un nivel alto.

Palomino²⁹ en 2022 publicó su estudio sobre Nivel de conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre LME en madres primíparas de niños menores de 06 meses Puesto de salud Chontapaccha-Cajamarca 2020. La metodología fue estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional, con una muestra de 59 madres. Sus resultados muestran que la mayoría de las madres tiene un nivel de conocimientos alto en 71.19% (42) y bajo en 28.81% (17) , casi toda la muestra presenta prácticas adecuadas y actitud positiva en más de la mitad de ellas.

Agama et al.³⁰ en 2024 realizaron su investigación sobre Nivel de conocimiento y Práctica sobre LME en madres primíparas del Hospital de Apoyo Huanta “Daniel Alcides Carrión”. Su metodología fue de enfoque cuantitativo, aplicada, descriptivo, correlacional y transversal. Los resultados de su estudio fueron que el 51.7% presentan un nivel de conocimiento medio y de ellas 41.7% realizaron prácticas inadecuadas y 10% adecuada; 36.7% tienen un nivel de conocimiento bajo y 35% de ellas realizaron prácticas inadecuadas; 11.7% tienen un nivel de conocimiento alto y 10% realizan prácticas adecuadas.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Que es conocimiento

Nonaka y Takeuchi³¹ señalan que existen dos tipos de conocimientos, uno es explícito y el otro tácito, el primero contenido en manuales y procedimientos y el segundo solo se aprende mediante la experiencia y

se comunica de manera indirecta a través de metáforas y analogías. Para Druker³² vivimos actualmente en la sociedad del conocimiento en donde se adquiere y se aplica conocimiento como un factor de competitividad, en ello radica la importancia de crear conocimiento.

Por otro lado, Segarra³³ señala que el conocimiento le concede al ser humano la capacidad de realizar distinciones o juicios según el contexto, es decir, emite un juicio según la habilidad y la situación; influye también el lenguaje como una herramienta cultural.

2.2.1.1 Nivel de conocimiento de la madre sobre LM

García et al.¹² señalan que el cuidado de la salud y el conocimiento tienen estrecha relación, influye el grado de instrucción del individuo ya que cuanto mayor es el grado de instrucción mayor será mejor el nivel de entendimiento y conocimientos en temas de salud, por otro lado, los de menor nivel de instrucción enfrentan mayores dificultades.

Freire et al.²¹ argumentan sobre la necesidad de una intervención educativa a las madres ya que los resultados de su estudio demuestran que existe un alto porcentaje de madres con bajos niveles de conocimiento sobre LM, resaltan la importancia de implementar estrategias educativas para elevar los conocimientos de las madres. Las investigaciones realizadas permiten visualizar esta problemática y los resultados obtenidos no demuestran que el 100% de la población en estudio mantienen niveles de conocimientos adecuados.

2.2.2 Lactancia materna

2.2.2.1 Lactancia materna exclusiva

De acuerdo con la OMS³⁴ la lactancia materna es un acto natural y un comportamiento aprendido por medio del cual la madre le proporciona un alimento ideal para un crecimiento y desarrollo sano a su hijo; al mismo tiempo, brinda a la madre beneficios para su salud. Al lactante le sirve como un estímulo para su desarrollo emocional y motriz, su coeficiente intelectual, el desarrollo visual, auditivo y comunicativo, siendo todos beneficios producto de la lactancia materna dentro de los seis primeros meses, conocida como LM exclusiva.

Así mismo, el ente rector en salud del Perú en su labor de promoción de la salud manifiesta la importancia de promover y apoyar la lactancia materna, además, la leche materna por su alto valor nutricional para los lactantes sobre todo los primeros seis meses de vida. Indica también que los beneficios no solo involucran al lactante sino a la madre, familia y comunidad; por medio de la lactancia materna la sociedad tiene la oportunidad de tener ciudadanos que desarrollan plenamente su potencial físico, emocional y cognitivo.³⁵

2.2.2.2 Anatomía y fisiología de la mama

La estructura del pecho materno incluye el pezón y la areola; el tejido mamario; el tejido conectivo de soporte y la grasa; los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios.³⁶

2.2.2.2.1 El tejido mamario: Incluye a los alvéolos, que son pequeños sacos compuestos por células secretoras de leche y a los conductos que transportan la leche al exterior. Entre las mamadas, la leche se almacena en el lumen de los alvéolos y de los conductos. Los alvéolos están rodeados por una 'canasta' de células

mioepiteliales (musculares), que se contraen y hacen posible que la leche fluya por los conductos.³⁶

2.2.2.2.2 Pezón y areola: El pezón tiene un promedio de nueve y nervios. El pezón está rodeado por la areola, que es circular y pigmentada, conductos lactíferos que lo atraviesan hacia el exterior y también tiene fibras musculares donde se encuentran localizadas las glándulas de Montgomery. Estas glándulas secretan un líquido aceitoso que protege al pezón y a la areola durante la lactancia y produce un olor particular, para cada madre, que atrae a su lactante hacia el pecho.³⁶

2.2.2.3 Etapas de la leche materna

2.2.2.3.1 Calostro: Es la leche espesa que es secretada durante los primeros días después del parto. Es un líquido amarillento de alta densidad, producida en pequeña cantidad, aproximadamente 40–50 ml en el primer día, pero esta cantidad es la que normalmente el recién nacido necesita en ese momento; los riñones inmaduros del neonato no pueden manejar grandes volúmenes de líquido; tanto el volumen del calostro como su osmolaridad son adecuados a su madurez.³⁷

Es rico en glóbulos blancos y anticuerpos y contiene un mayor porcentaje de proteínas, minerales y vitaminas liposolubles (A, E y K) en comparación con la leche madura; la vitamina A es importante para la protección de los ojos y para la integridad de las superficies epiteliales. Proporciona una importante protección

inmunológica al lactante al estar expuesto por primera vez a los microorganismos del ambiente.³⁷

Entre los beneficios del calostro se tiene que contiene Inmunoglobulinas (IgG, IgA y IgM), principalmente la inmunoglobulina A, la cual recubre la mucosa intestinal y evita que las bacterias penetren a las células; oligosacáridos, que evitan que las bacterias se adhieran a la superficie de las mucosas. Facilita la reproducción del lactobacilo bífido en el lumen intestinal del recién nacido que es una barrera ante infecciones.³⁷

El bajo pH resultante en el lumen intestinal dificulta el desarrollo del escherichia coli y hongos como cándida albicans. Un pH bajo en el estómago puede ser de gran importancia para el prematuro y el recién nacido de bajo peso.³⁷

Los antioxidantes y las quinonas que aporta son necesarias para protegerlo del daño oxidativo y la enfermedad hemorrágica, inhibe la formación de IgE, que es la principal inmunoglobulina implicada en las reacciones alérgicas, proteínas del suero (lisozima y lactoferrina) que destruyen bacterias, virus y hongos, facilita la eliminación del meconio (primeras heces) y ayuda a reducir la absorción de bilirrubina y los problemas de ictericia. Si el bebé ingiere la leche materna suficiente, eliminará el excedente de bilirrubina a través de las heces.³⁷

2.2.2.3.2 Leche de transición: Se produce entre el cuarto y el décimo día postparto. Su contenido es mayor en lactosa, grasas,

calorías y vitaminas hidrosolubles. Llamada también bajada de la leche por el aumento brusco hasta llegar aproximadamente 400 a 600 ml/día.³⁸

2.2.2.3.3 Leche madura: Se produce a partir del décimo día. Con un volumen promedio diario de 700 a 800 ml.³⁸

2.2.2.4 Componentes de la leche materna

La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los primeros seis meses de vida, incluyendo grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua.³⁸

2.2.2.4.1 Grasas: La leche humana contiene aproximadamente 3.5 g de grasa por 100 ml de leche. La grasa de la leche materna contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (ácido docosahexaenoico o ADH y ácido araquidónico o AA) la cual no se encuentran presentes en otras leches. Estos ácidos grasos son importantes para el desarrollo neurológico del niño.³⁸

2.2.2.4.2 Hidratos de carbono: El principal hidrato de carbono de la leche materna es la lactosa, la leche materna contiene aproximadamente 7 g de lactosa por 100 ml. Otro tipo de hidratos de carbono son los oligosacáridos, que brindan una importante protección contra la infección.³⁸

2.2.2.4.3 Proteínas: La concentración de proteína en la leche materna es de 0.9 g por 100 ml en comparación con la leche animal. La mayor cantidad de proteína que existe en la leche animal puede sobrecargar los riñones inmaduros del lactante. La leche materna contiene una menor cantidad de proteína llamada caseína, la cual

tiene una estructura molecular diferente. La caseína de la leche materna forma cuajos que son más fáciles de digerir que los que se forman con otras leches.³⁸

2.2.2.4.4 Vitaminas: La leche humana contiene todas las vitaminas. Dado que su concentración de Vitamina K es baja, a todo recién nacido se le debe aplicar una dosis de prevención por vía intramuscular al nacer. Existen variaciones en las vitaminas hidrosolubles, y dependen de la dieta de la madre.³⁸

2.2.2.4.5 Hierro: La leche humana contiene cantidades pequeñas, con relación al hierro contenido en la leche de vaca, pero la absorción de éste es mayor, evitando el desarrollo de anemia en los lactantes, (absorción de 48% a partir de la leche humana, 10% en la leche de vaca y sólo el 4% en las fórmulas comerciales).³⁸

2.2.2.4.6 Calcio/fósforo: La relación calcio/fósforo es de 2 a 1 en la leche humana, lo que favorece la absorción del primero (30 y 15 mg/100 ml de calcio y fósforo respectivamente).³⁸

2.2.2.5 Beneficios para el recién nacido

La leche materna es la mejor protección para el niño contra las diarreas y la deshidratación, las infecciones respiratorias como la bronquitis y neumonía, estreñimientos, cólicos y alergias, enfermedades de la piel como granos y sarpullido, sarampión, cólera y desnutrición, diabetes y deficiencia de micronutrientes.³⁹

2.2.2.6 Beneficios para la madre

Para la madre existen múltiples ventajas entre ellas están que la placenta sale con mayor facilidad y rápidamente, hay menor hemorragia y

disminuye el riesgo de anemia, la matriz recupera su tamaño normal rápidamente, al bajar la leche la madre tendrá sus pechos menos congestionados, la leche baja más rápido si el niño empieza a mamar desde que nace, la madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche, menor riesgo de cáncer de seno o de ovario, menor riesgo que la madre quede embarazada nuevamente y se fomenta el vínculo de amor y apego.³⁹

2.2.3 Técnicas de amamantamiento

Para que una lactancia materna sea exitosa depende mucho de una adecuada técnica de amamantamiento, de la disposición y confianza de la madre, el equipo de salud debe demostrar preocupación y a la vez promover, apoyar, enseñar y facilitar todo el conocimiento necesario sobre la lactancia materna siendo algo natural y a su vez importante para el lactante menor de seis meses.⁴⁰

La madre al momento de lactar tiene que adoptar una buena y cómoda posición esto ayuda a mantener la producción de leche, así la madre evita el cansancio y que se lastimen sus pezones.⁴⁰

2.2.3.1 Posiciones del niño con la madre sentada

Cuando la madre amamanta sentada debe hacerlo en una silla cómoda, donde pueda apoyar bien la espalda. Es más cómodo para ella apoyar los pies sobre un pequeño piso y colocar un cojín sobre las piernas para de esta forma dar altura al niño y acomodarlo a la altura del pecho.⁴⁰

2.2.3.2 Madre sentada y niño acunado, clásica

Esta es una de las posiciones más conocidas, el niño acostado frente a la madre a la altura de los pechos, el abdomen del niño debe quedar frente a la madre, el brazo de esta sirve de apoyo al cuerpo y cabeza del niño, con la mano en forma de “C” la madre ofrece el pecho, con el pezón estimula el labio inferior del niño para que abra la boca, en ese momento acerca el niño hacia el pecho de tal forma que el pezón y la areola queden dentro de la boca del niño. El brazo del niño que queda por debajo se ubica bajo el pecho de la madre o rodeando su cintura.⁴⁰

2.2.3.3 Posición de caballito

La madre sentada y el niño enfrente el pecho sentado sobre la pierna de esta, la madre afirma al niño con el brazo del mismo lado en que está el niño, la mano en forma de “C” y los dedos del medio y pulgar detrás de las orejas, con la mano libre ofrece el pecho. No apoyar la palma de la mano en la parte posterior de la cabeza ya que el niño responderá con un reflejo de extensión que lo hará llevar la cabeza hacia atrás y alejarse del pecho. Esta posición está recomendada para los niños hiper y/o hipotónicos, niños con fisura palatina, mamas muy grandes.⁴⁰

2.2.3.4 Posición en reversa

La madre sentada y el niño acostado sobre un cojín para levantarlo a la altura de los pechos. Con la mano libre la madre ofrece el pecho, con la otra sobre la palma sostiene la cabeza del niño. Esta posición permite deslizar al niño de un pecho a otro sin cambiarlo de posición, esta

posiciónse recomienda cuando el niño tiene preferencia por un pecho y cuando el niño tiene problemas con la clavícula.⁴⁰

2.2.3.5 Posición en canasto o pelota

En esta posición se ubica al niño debajo del brazo del lado que va a amamantar, con el cuerpo rodeando la cintura de la madre. La madre maneja la cabeza del niño con la mano del lado que amamanta, tomándolo por la base de la nuca. Esta posición se recomienda para alimentar gemelos en forma simultánea, en caso de cesárea para no presionar la zona de la herida operatoria.⁴⁰

2.2.4 Extracción y conservación de la leche materna

Al iniciar la extracción la madre debe realizar un buen lavado de manos con agua y jabón y secarlas con una toalla o un trapo bien limpio que sea de uso exclusivo; además debe mantener la limpieza y corte de uñas, mantener limpio y sujetado el cabello para no contaminar la leche al momento de extraer. También lavar con agua caliente el recipiente donde se almacenará la leche y evitar hablar durante la extracción.⁴¹

2.2.4.1 Pasos para extraer la leche materna

La madre realizará masaje circular con la yema de los dedos en diversos puntos alrededor del seno materno, durante 2 minutos; los dedos de la madre (el pulgar e índice) en forma de “C”, a dos centímetros por encima y debajo del pezón. Debe frotar suavemente el seno materno deslizando de atrás hacia delante. Junta los dos dedos entre sí, sin moverlos del sitio cambiando la orientación de los dedos en diferentes puntos alrededor de la areola y repetirá la maniobra.⁴¹

Hará presión y soltará, esto no debe doler; si es así la técnica está

equivocada. Puede que no salga leche al comienzo, pero después de hacer presión unas pocas veces la leche comienza a gotear, a lo cual pueden seguir “chorros” de leche si el reflejo de oxitocina está activo. La madre debe extraer leche de un pecho durante por lo menos tres a cinco minutos hasta cuando el flujo disminuya, luego “ordeñar” el otro lado, y luego repetir en los dos lados. La extracción adecuada de la leche toma entre veinte y treinta minutos.⁴¹

2.2.4.2 La extracción es útil para aliviar un conducto obstruido o escasez de leche, alimentar a un lactante mientras aprende a succionar un pezón invertido, alimentar a un lactante con dificultades para coordinar la succión, alimentar a un lactante con bajo peso que no puede mamar todavía, alimentar a un lactante enfermo cuya succión es débil, mantener la producción de leche cuando la madre o el lactante están enfermos y cuando la madre deba ir a trabajar.⁴¹

2.2.5 Teoría del apego

Según Bowlby la salud mental de los niños a corto, mediano y largo plazo depende de una relación madre hijo que sea cálida, íntima y continua, lo cual les concede satisfacción y alegría. En su teoría el autor indica que existen varios tipos de apego, entre ellos está el apego desorganizado, el apego seguro y el apego inseguro. El apego la define como un vínculo confiable y seguro que brinda un cuidador constante y atento que se comunica con el bebé permanentemente, es una entrega casi total de la madre para atender todas las necesidades de su hijo en los primeros meses de vida.⁴²

El tipo de apego seguro puede brindar un adecuado desarrollo cognitivo y mental del niño hasta llegar a la edad adulta, aunque incluya algún riesgo genético. Por tal razón, es importante una vigilancia por profesionales de salud desde el primer momento de vida, que permitirá detectar algún vínculo defectuoso. La enfermera en el control del recién nacido debe observar las conductas entre la madre e hijo para fomentar el apego, considerando que es entre los 0 y 3 años que los niños desarrollan su capacidad cerebral al máximo.⁴²

2.2.6 Rol de la enfermera

La participación de la enfermera en la promoción de la lactancia materna es activa en cuanto al aspecto educativo, forma parte del equipo de profesionales de la salud que deben mantenerse capacitados y actualizados en lo relacionado a la lactancia materna a fin de proteger la salud de los lactantes.³²

El rol de la enfermera en todos los niveles de atención es brindar consejería desde la etapa preconcepcional, apoyando a la pareja, familia y comunidad, fortaleciendo la confianza de las madres resolviendo todas las dudas y erradicando falsas creencias a fin de que las madres ejerzan su derecho de amamantar a sus hijos.³⁴

2.2.7 Teoría de Adopción del Rol maternal de Ramona Mercer

2.2.7.1 Rol materno

Se inicia desde la concepción y es un proceso interactivo donde la madre va creando un vínculo con su hijo lo cual favorece su desarrollo; es una etapa de aprendizaje donde brinda cuidados, aprende diversas tareas y en cada etapa la madre experimenta satisfacción y alegría con su nuevo rol.¹⁹

La madre va logrando competencias en el cuidado de su hijo, según lo expresa Mercer, ya que experimenta capacidades para brindar un cuidado como experta sabiendo como, que, cuando y por que hace algo por su hijo lo cual va a permitir un adecuado desarrollo y bienestar a su hijo¹⁹.

2.2.7.2 Papel de la enfermera

La enfermera cumple un papel de acompañante y guía para la madre a fin de que pueda alcanzar con éxito su rol. Le ayuda a identificar factores internos que pueden afectarle en el logro como la depresión postparto, que muchas veces impide a la madre brindar los cuidados apropiados entre ellos la lactancia materna exclusiva²⁰.

También existen factores externos que pueden afectar a la madre para cumplir con éxito su nuevo rol, por ejemplo, el temperamento y carácter del nuevo ser, la familia y la sociedad.

La enfermera debe ayudar a la madre a propiciar aquellas actitudes maternas para la alimentación de su niño, además de proporcionarle la educación y orientación que necesita a fin de fomentar creencias positivas y erradicar las negativas. De acuerdo con la teoría, la enfermera debe promover la vinculación madre-hijo, desde la etapa del puerperio y durante los controles del niño en el primer nivel de atención.²⁰

2.2.8 Cuidados de enfermería en salud neonatal

La participación de la enfermera en la atención inmediata del recién nacido permite el acercamiento directo con la madre en la etapa del puerperio, es cuando refuerza los conocimientos de la madre sobre las técnicas de amamantamiento correctas, incidiendo en los aspectos de higiene y cuidado de

los pezones, explicando a la madre todo lo necesario para brindar una lactancia materna segura.¹⁵

2.2.9 Cuidados de enfermería en crecimiento y desarrollo

En la etapa de los primeros controles del recién nacido la enfermera realiza sus funciones de verificar el crecimiento y desarrollo normal del lactante menor, y uno de los aspectos es la alimentación, es a través de la lactancia materna que el niño logrará el peso y talla adecuados, así como un desarrollo psicomotor apropiados.¹⁷

Luego la madre continuará con los controles mensuales del niño, durante los primeros seis meses y la enfermera debe verificar y asegurarse que la madre lo amamante de manera exclusiva en este periodo. Ella debe conocer las ventajas y desventajas de recibir o no lactancia materna, de esta manera asegurar la salud de su hijo.¹⁷

La enfermera del primer nivel de atención realizará sus actividades intra y extramurales con el fin de que las madres se mantengan permanentemente informadas y capacitadas para ayudar en su comunidad a las futuras madres y así promover la lactancia materna, mediante talleres, capacitaciones, sesiones educativas y demostrativas, utilizando técnicas de escucha activa y comunicación asertiva. Promoviendo la interculturalidad respetando sus creencias, erradicando mitos y creencias a través de mantener un proceso de educación continua.¹⁷

2.3 Definición de términos básicos

Nivel de conocimiento de la madre:

Medida en términos cuantitativos de conocimientos que posee la madre sobre algún tema o asunto. De la lactancia materna, interesa conocer cantidad y

calidad de conocimientos que posee para el mantenimiento de la salud del lactante.

Lactancia materna exclusiva:

Es la lactancia materna que se mantiene de manera continua y exclusiva durante los primeros seis meses de vida del lactante.

Amamantamiento:

Es el acto de alimentar con leche materna a un lactante directamente de los senos de la madre, se inicia desde su nacimiento.

Apego madre-hijo:

Es el vínculo o conexión emocional, física y psicológica que se pone de manifiesto después del parto, pero se inicia desde el embarazo. Es fundamental para el desarrollo del bebé y tiene repercusiones importantes a lo largo de su vida.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas

El presente trabajo de investigación por ser de tipo descriptivo no requiere de formulación de hipótesis.

3.2 Variables y definición operacional

Variable	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala
Nivel de Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva	Es toda la información que posee la madre acerca de la lactancia, donde se incluye frecuencia, duración, beneficios para el niño y la madre e importancia de esta.	Aspectos generales	- Conceptos de lactancia materna - Anatomía y fisiología de la mama - Etapas de la leche materna - Composición de la leche materna	1,2,3,4,5,6,7	Escala de estadios Nivel de conocimiento Alto : 14-16 Medio : 9-13 Bajo : 4 - 8
		Técnicas de amamantamiento	- Posiciones - Técnicas de amamantamiento	8,9,10,11,12, 13,14	
		Extracción de la leche materna	- Importancia de la extracción - Higiene en la extracción - Extracción manual de leche materna - Utilización de la leche materna	15,16,17,18, 19,20	

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, de corte transversal y prospectivo.

4.2 Diseño muestral

La población la constituyen las madres con hijos menores de seis meses quienes acuden al Control de Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud Breña. El total de la población son alrededor de 90 madres. El tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia.

Criterios de inclusión:

- Madres que aceptan participar y firmen el consentimiento informado
- Madres primigestas o multíparas
- Madres sin distingo de edad

Criterios de exclusión:

- Madres de niños mayores de seis meses
- Madres quechua hablantes u otros dialectos
- Madres con niños que tengan alguna restricción médica y no reciban lactancia materna

4.3 Técnica de recolección de datos

La técnica a utilizar será la entrevista y el instrumento es una encuesta cuyos autores son Bocanegra et al.⁷, 2016, es un cuestionario de 20 preguntas estructurado en tres dimensiones: Aspectos generales de la lactancia materna (7 preguntas), Técnicas de amamantamiento (7 preguntas) y Extracción de la leche materna (6 preguntas).

El instrumento presenta una confiabilidad por juicio de 6 expertos mediante Prueba binomial cuyo puntaje por concordancia de expertos es de 0.0156 ($p < 5\%$, error de significancia máximo).

4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Para el procesamiento de la información se utilizará el programa SPSS versión 27 el cual permite obtener las tablas con la estadística descriptiva.

4.5 Aspectos éticos

Se consideran los 4 aspectos éticos para llevar a cabo la investigación:

Justicia

Los participantes son seleccionados de manera justa sin distinción de ningún tipo ya sea condición económica, raza, sexo o religión.

Autonomía

Cada madre es libre de participar en la investigación y firmarán el consentimiento informado para tal fin.

Beneficencia

Se garantiza la reserva y confidencialidad de la información de las participantes y solo serán utilizados para los fines de la investigación.

No maleficencia

Se atenderá a las madres con respeto, cuidando su integridad física y psicológica, bajo el principio de no causar daño ni algún tipo de mal.

CRONOGRAMA

N°	Actividades	Meses				
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
1	Identificación y formulación del problema	X				
2	Revisión de las fuentes de información	X				
3	Redacción de objetivos y operacionalización de las variables		X			
4	Determinación del diseño de investigación		X			
5	Determinación del marco muestral			X		
6	Selección de los estadígrafos a utilizar			X		
7	Recolección de datos				X	
8	Organización y procesamiento de los datos				X	
9	Análisis e interpretación de los resultados				X	
10	Redacción del informe					X
11	Presentación del informe					X

PRESUPUESTO

Tipo	Servicios	Unidad	Costo unidad	Monto total
Recursos humanos	Encuestadores			100
	Personal para la tabulación			100
	Análisis estadístico			300
	Traducción del documento en ingles			100
	Sub total			600
Adquisición de bienes	Material de escritorio (hojas, tóner de impresión, lapicero)			150
	Incentivo para participantes			250
	Sub total			400
Servicios	Internet			150
	Impresión de cuestionarios y fotocopia de documentos			100
	Movilidad			100
	Sub total			350
Total general				1,350

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gamboa E. Genealogía histórica de la lactancia materna. Rev. Enf. Actual [Internet]. 2008 [Citado 13 de mayo 2025]; 15 (2): 1-6 Disponible de: https://www.researchgate.net/publication/28233949_Genealogia_historica_de_la_lactancia_materna
2. Perales J, Pina B. Aspectos socioculturales de la lactancia materna en niños mayores. Rev Pediatr Aten Primaria [Internet]. 2017 [Citado 13 de mayo 2025]; 19:337-44 Disponible de: <https://scielo.isciii.es/pdf/pap/v19n76/1139-7632-pap-21-76-00337.pdf>
3. Aguilar M, Sánchez A, Madrid N, Mur N, Expósito M, Hermoso E. Lactancia materna como prevención del sobrepeso y la obesidad en el niño y el adolescente; revisión sistemática. Nutr Hosp [Internet]. 2015 [Citado 13 de mayo 2025]; 31(2):606-620 Disponible de: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v31n2/10revision09.pdf>
4. Gerd A, Bergman S, Dahlgren J, Roswall J y Alm B. Factors associated with discontinuation of breastfeeding before 1 month of age. Acta paediatr [Internet]. 2012 [Citado 13 de mayo 2025]; 101(1): 55-60. Disponible de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21767302/>
5. Lozano M. Lactancia Materna. Protocolos diagnósticos terapéuticos [Internet]. 2010 [Citado 13 de mayo 2025]; 279-286 Disponible de: <https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-05/Protocolos%20SEGHNP.pdf>

6. Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. [Internet]. Roma: FAO, 2022. El estado de la nutrición: progresos en relación con las metas mundiales de nutrición [Citado 14 de mayo 2025] Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/7401e23d-78f8-48ef-a38f-3d93e841d766/content/sofi-2022/global-nutrition-targets-trends.html>
7. Fondo de la Naciones Unidas para la infancia. [Internet]. Nueva York: UNICEF, 2024. Lactancia materna nutrición y protección para el bebé [Citado 14 de mayo 2025] Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/lactancia-materna>
8. Fondo de la Naciones Unidas para la infancia. [Internet]. Nueva York: UNICEF, 2023. Global breastfeeding scorecard 2023 [Citado 14 de mayo 2025] Disponible en: <https://www.unicef.org/media/150586/file/Global%20breastfeeding%20scorecard%202023.pdf>
9. Organización Panamericana de la Salud. [Internet]. Washington D.C.: OPS, 2025. Lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses [Citado 14 de mayo 2025] Disponible en: <https://www.paho.org/en/enlace/exclusive-breastfeeding-infant-under-six-months-age>
10. Alavi, M., & Leidner, D. Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly [Internet]. 1998 [Citado 14 de mayo 2025]; 40pp. Disponible de: https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp1998/98-57.pdf
11. Bocanegra L, Espinoza M, Ruiz A. Efectividad de una intervención educativa de enfermería sobre lactancia materna exclusiva en el conocimiento de primigestas adolescentes que acuden al centro de salud Laura Caller, Los Olivos, 2016. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Callao: Universidad

Nacional del Callao, 2016 [Citado 14 de mayo 2025]; 136 pp. Disponible en:
<https://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/1730>

12. García A, Condori M. Nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres de niños menores de seis meses que acuden a control de niño sano en el Centro de Salud Mariano Melgar, Arequipa 2024. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Arequipa: Universidad Católica de Santa María, 2024 [Citado 14 de mayo 2025]; 80pp. Disponible en:
<https://repositorio.ucsm.edu.pe/items/5b112b3b-a977-4e67-910d-1e786b56a9d1>
13. Tellez-Perez E, Romero-Quechol, G, Galván-Flores G. Conocimientos sobre Lactancia Materna de mujeres puérperas que acuden al primer nivel de atención. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc [Internet]. 2020 [Citado 14 de mayo 2025]; 27(4); 196-205. Disponible de:
<https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2019/eim194c.pdf>
14. Carrasco M, Saile L. Nivel de Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en madres de lactantes menores ingresadas en el área de hospitalización Materno Infantil del hospital Teodoro Maldonado Carbo 2020-2021 [Tesis para Título Profesional en Internet]. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2021 [Citado 14 de mayo 2025]; 83pp. Disponible en:
<http://www.htmec.gob.ec:8080/jspui/handle/123456789/219>
15. Ministerio de Salud del Perú [Internet] Lima: MINSA; c2024. Nota de prensa: El 65.9% de menores de seis meses cuenta con lactancia materna exclusiva [Citado 14 de mayo 2025]. Disponible de:
<https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1021904-el-65-9-de-menores-de-seis-meses-cuenta-con-lactancia-materna-exclusiva>

16. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico [Internet] Lima: CEPLAN; c2024.
Nota de prensa: Incremento de la lactancia materna exclusiva [Citado 14 de mayo 2025]. Disponible de: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/ts_3_salud
17. Perú. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal [Internet] Resolución Ministerial N° 545-2024/MINSA (2024 Ago 15) [Citado 14 de mayo 2025]. Disponible de: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/fi-admin/RM-545-2024-minsa.pdf>
18. Perú. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la niña y el niño menor de cinco años [Internet] Resolución Ministerial No 537-2017/MINSA (2017 Jul 10) [Citado 14 de mayo 2025]. Disponible de: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190581-537-2017-minsa>
19. Ortiz-Félix R, Cárdenas-Villarreal V, Flores-Peña Y. Modelo de rol materno em la alimentación del lactante. Index Enferm [Internet]. 2016 [Citado 18 de junio 2025];25(3):166-170 Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/316507035_Model_maternal_role_in_infant_feeding_Middle_range_theory
20. Husmillo, M. Maternal Role attainment theory. Internat Journal Childbirth Educ [Internet]. 2013 [Citado 18 de junio 2025];28(2):46-48 Disponible en: <https://research.ebsco.com/c/g36vig/viewer/pdf/ltj6xwawtb>
21. Freire S, Caluña I. Conocimientos, actitudes y practicas sobre lactancia materna exclusiva: perspectivas en gestantes y madres postparto. Nutr Clin Diet Hosp [Internet]. 2025 [Citado 12 de mayo 2025];45(1):445-450 Disponible en: <https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/871>

22. Hernández A, Hierrezuelo N, González C, Gómez U, Fernández L. Conocimientos de padres y madres sobre lactancia materna exclusiva. Medisan [Internet]. 2023 [Citado 12 de mayo 2025];27(2): pág.: e4336 Disponible en: <https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/4336/pdf>
23. Salazar A, García L, Perdomo A, López I. Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en primigestantes que asisten a control prenatal en Neiva, 2020. Rev Neuronum [Internet]. 2020 [Citado 12 de mayo 2025]; 6(3): págs. 7-24 Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9690912>
24. Carrasco M, Saile L. Nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres de lactantes menores ingresadas en el área de hospitalización materno infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 2021. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2021 [Citado 12 de mayo 2025]; 83 pp. Disponible en: <http://201.159.223.180/handle/3317/17154>
25. Romero H, Chuquimarca R, Álvarez B. Conocimientos sobre lactancia materna em niños menores de 2 años de edad de la Universidad Técnica de Babahoyo. Rev Ciencia e Investig [Internet]. 2023 [Citado 12 de mayo 2025]; 8(4): págs. 85-99 Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9143400>
26. Quispe N. Nivel de conocimientos y su relación con las prácticas de lactancia de las madres con niños menores de 06 meses, centro de salud San Genaro-Chorrillos Lima, 2022. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Lima: Universidad Norbert Wiener, 2022 [Citado 12 de mayo 2025]; 73pp. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ee31edc1-bd74-495e-adbd-3cc5ed0b74dd/content>

27. Gutiérrez W. Conocimientos y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en madres multíparas en el servicio de CRED del Hospital Nacional 2 de Mayo. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020 [Citado 12 de mayo 2025]; 57pp. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/4264>
28. Capulian D, Cabezas J. Nivel de conocimiento y actitud sobre la LM en madres de niños menores de 3 años, Hospital Alberto Sabogal Sologuren 2021. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Chíncha: Universidad Autónoma de Ica, 2022 [Citado 12 de mayo 2025]; 88 pp. Disponible en: <https://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/2127>
29. Palomino M. Nivel de conocimientos, prácticas y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas de niños menores de 6 meses Puesto de salud Chontapaccha Cajamarca. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca, 2022 [Citado 12 de mayo 2025]; 118 pp. Disponible en: <https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/4976>
30. Agama L, Arones L. Nivel de conocimiento y practica sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas del Hospital de Apoyo Huanta “Daniel Alcides Carrión” Huanta Ayacucho, 2023. [Tesis para Título Profesional en Internet]. Ayacucho: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 2024 [Citado 12 de mayo 2025]; 86 pp. Disponible en: <https://repositorio.unsch.edu.pe/items/c125fbfb-9473-427b-8664-6c602040c445>

31. Nonaka I, Takeuchi, H. La organización creadora de conocimiento. [Internet]. 1a ed. México: Oxford University Press; 1995 [Citado 20 de mayo 2025]. 60-103p. Disponible de: <https://fvicario.com/temas/nonaka.pdf>
32. Terán F. Sociedad del conocimiento y la economía. Innova research journal [Internet]. 2018 [Citado 20 de mayo 2025]; 3(5): págs. 146-154 Disponible en: <https://revistas.uide.edu.ec/index.php/innova/article/view/542/681>
33. Segarra M, Bou J. Concepto, tipos y dimensiones del conocimiento: configuración del conocimiento estratégico. https://www.researchgate.net/publication/28185756_Concepto_tipos_y_dimensiones_del_conocimiento_configuracion_del_conocimiento_estrategico
34. Perú. Ministerio de Salud. Guía técnica para la consejería en Lactancia Materna [Internet]. Resolución Ministerial No 462-2015/MINSA (2015 Jul 31) [Citado 21 de mayo 2025]. Disponible de: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4928.pdf>
35. Ministerio de Salud del Perú [Internet] Lima: MINSA; c2022. Nota de prensa: Minsa: lactancia materna es un derecho del bebé y la madre [Citado 21 de mayo 2025]. Disponible de: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/618664-minsa-lactancia-materna-es-un-derecho-del-bebe-y-la-madre>
36. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington: OPS; c2009. Alimentación del lactante y del niño pequeño [Citado 21 de mayo 2025]. 173pp. Disponible de: <https://www3.paho.org/hq/dmdocuments/2010/La-alimentacion-del-lactante--capitulo-modelo-para-libros-de-texto.pdf>
37. Facultad de Ciencias de la Vida. Colostrum, the newborn's first defense [Internet]. 2022 [Citado 15 de julio 2022]. Disponible de: <https://www.fcv.espol.edu.ec/archive/es/calostro-la-primera-defensa-del-reci%C3%A9n-nacido>

38. Sabillón F, Abdu B. Composición de la leche materna. Rev Honduras Pediátrica [Internet]. 1997 [Citado 22 de mayo 2025]; XVIII (4): págs. 120-124 Disponible en: <http://www.bvs.hn/RHP/pdf/1997/pdf/Vol18-4-1997-7.pdf>
39. Fondo de la Naciones Unidas para la infancia. [Internet]. Nueva York: UNICEF, 2012. Lactancia materna [Citado 22 de mayo 2025] Disponible en: <https://www.unicef.org/ecuador/media/2611/file/lactancia%20materna.pdf>
40. Ministerio de Salud de Chile. Manual de lactancia materna [Internet]. 1997 [Citado 22 de mayo 2025]. Disponible de: https://www.academia.edu/40163940/Lactancia_Materna_CONTENIDOS_T%C3%89CNICOS_PARA_PROFESIONALES_DE_LA_SALUD
41. Instituto Nacional de Salud. Técnicas de extracción, conservación y forma adecuada de dársela al niño [Internet]. 2022 [Citado 22 de mayo 2025]. Disponible de: <https://alimentacionsaludable.ins.gob.pe/ninos-y-ninas/lactancia-materna/tecnicas-de-extraccion-conservacion-y-forma-adecuada-de-darsela-0>
42. Moneta M. Apego y pérdida: redescubriendo a Jhon Bowlby. Rev Chil Pediatr [Internet]. 2014 [Citado 22 de mayo 2025]; 85(3): págs. 265-268 Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v85n3/art01.pdf>

ANEXOS

ANEXO A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CONOCIMIENTO SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

La participación en esta investigación es completamente voluntaria y no le generara ningún riesgo. Sus datos personales que sean obtenidos en la investigación tendrán una total privacidad y no serán públicos en la presentación de los resultados.

I. Datos generales:

Edad:.....

Estado civil:.....

Escolaridad:.....

Ocupación:.....

Ha recibido anteriormente educación sobre lactancia materna:

Sí() No() especificar:

MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE USTED CREA CONVENIENTE:

1. La lactancia materna exclusiva se da hasta la edad de:

- a) 2 años a mas
- b) 1 año a mas
- c) 6 meses de edad
- d) 4 años a mas

2. La mayor cantidad de leche que produce la madre depende de:

- a) El tamaño de las mamas.
- b) la buena succión del bebe.
- c) Que la madre coma muchas verduras.
- d) Peso de la madre.

3. ¿Cuáles son los componentes de la leche Materna?

- a) Agua, azúcar, sales.
- b) Grasas, azúcar y agua
- c) Proteína, minerales, Agua, carbohidratos, grasas y vitaminas.
- d) Azúcar, minerales, proteínas.

4. El calostro es la primera secreción láctea muy concentrada en:

- a) Proteínas
- b) Vitamina A
- c) Anticuerpos (defensa para el cuerpo del bebe)
- d) Todas son correctas

5. El calostro beneficia al bebe en:

- a) En la eliminación de su primera deposición (meconio)
- b) Brinda protección de cualquier virus, bacteria que puede entrar al sistema digestivo).
- c) ayuda en la aparición de los dientes.
- d) a y b son correctas

6. ¿Cuándo es que la leche materna beneficia a la madre?

- a) Sirve como un método Anticonceptivo, cuando él bebe lacta seguido de 18 a 20 veces al día.
- b) Mejora la digestión
- c) Es económico porque la madre no gasta en biberones, en luz, en gas o electricidad
- d) a y c son correctas

07. La lactancia materna exclusiva beneficia al bebé, en:

- a) El óptimo crecimiento y desarrollo por que ayuda a la formación de función cerebral, lenguaje, caminar.
- b) Protege contra las enfermedades por que recibe defensas para su sistema inmunológico.
- c) Fortalece el vínculo madre –hijo por que mediante el estímulo le brinda seguridad y protección.
- d) Todas las anteriores son correctas.

08.¿Qué señales nos indican que hay una correcta técnica de amamantamiento?

- a) El bebé succiona y traga leche de forma rítmica y regular.
- b) Mueve las mandíbulas a la altura de los oídos y los labios.
- c) a y b
- d) se le hunden las mejillas al succionar y se oyen chasquidos

09. ¿Qué señales nos indican que el bebé tiene un correcto agarre del seno de la madre durante del amamantamiento?

- a) Boca bien abierta.
- b) Labio inferior evertido.
- c) Mentón presionando la parte inferior de la mama
- d) Todas son correctas

10. Una correcta postura de la madre y posición del bebe debe cumplir con:

- a) La Madre se encuentra relajada y cómoda ,la Cabeza y cuerpo del bebé se encuentran alineados .
- b) a y c
- c) Cuerpo del bebé cerca, de frente al pecho de la madre.
- d) La madre tiene hombros tensos y se inclina sobre el bebé.

11. ¿Cuál es la posición que usted adoptaría para el amamantamiento?

- a) Mamá en posición sentada
- b) Mamá en posición acostada
- c) Mamá adopta cualquier posición que se sienta cómoda.
- d) Todas son correctas

12. ¿Con que frecuencia debes dar de lactar a su bebe?

- a) Cada media hora.
- b) Cada 2 horas.
- c) Cada vez que él bebe lo requiera.
- d) Cada 5 horas.

13. El tiempo de lactancia por cada seno de la madre depende de:

- a) Un buen agarre ya que determina el vaciado de leche del seno de la madre.
- b) La postura de la madre.
- c) La posición del bebé.
- d) La cantidad de leche producida por la madre.

14. Las consecuencias en la madre por mala técnica de amamantar son:

- a) Mastitis
- b) No sale leche del pezón
- c) Grietas en el pezón.
- d) Todas las anteriores son correctas.

15. ¿En qué situaciones es útil que una madre se extraiga la leche?

- a) Alimentar a un bebé con dificultades para la succión.
- b) Para dejarle leche materna al bebé cuando debe ir a trabajar.
- c) Para aliviar las mamas cuando hay retención de leche.
- d) Todas son correctas.

16. ¿Cuáles son las medidas higiénicas que se debe tener para la extracción de leche?

- a) Buen lavado de manos y limpieza de uñas, desinfección del recipiente para leche, evitar hablar durante la extracción.
- b) Descartar las primeras gotas de leche, preparar el recipiente para la leche.
- c) Lavado de manos y del pezón con abundante agua y jabón
- d) Solo un buen lavado de manos es suficiente.

17. ¿Cómo se puede estimular la producción de leche para la extracción?

- a) Poner paños tibios y beber bebidas calientes como café, té o manzanilla.
- b) Mantener contacto con el bebé, dar masajes a los pechos y tomar abundante leche de vaca.
- c) Mantener contacto directo con el bebé, poner paños tibios y masajear los pechos, además alguien puede frotarle la espalda.
- d) Mantener contacto con el bebé, poner paños tibios pero no se debe masajear los pechos porque son delicados.

18. ¿Cuál es el orden de los pasos de la extracción de leche materna?

1



Colocar la mano en forma de "C", por debajo de del pecho y detrás de la areola

2



Presione por detrás del pezón y la areola entre sus dedos índice y pulgar.

3



Masaje alrededor del pecho, en forma circular.

- a) 2, 3, y 1.
- b) 3, 1 y 2.
- c) 2, 1 y 3.
- d) 1, 2 y 3

19. ¿Cómo se debe conservar la leche materna?

- a) Colocar en el recipiente de la leche la fecha y hora de extracción, el envase debe ser de plástico, luego mantener la leche refrigerada
- b) Colocar en el recipiente de la leche la fecha y hora de extracción, el envase debe ser de vidrio y estar desinfectado, mantener la leche tibia.
- c) El envase puede ser cualquier recipiente de cocina pequeño, mantener la leche refrigerada.
- d) Colocar en el recipiente de la leche la fecha y hora de extracción, el envase debe ser de vidrio y estar desinfectado, luego mantener la leche refrigerada.

20. ¿Cómo se debe dar la leche materna conservada al bebé luego de calentarla?

- a) El bebé debe estar semi sentado, se debe hacer uso del biberón y se puede volver a congelar y utilizar la leche que el bebe dejó de tomar.
- b) El bebé debe estar echado, se debe usar una taza pequeña y se puede volver a congelar y utilizar la leche que el bebe dejó de tomar.
- c) El bebé debe estar semi sentado, se debe usar solo una taza, un vaso o una cucharita, no se debe volver a congelar y utilizar la leche que el bebé dejó de tomar.
- d) El bebé debe estar echado, se debe usar solo una taza, un vaso o una cucharita, no se debe volver a congelar y utilizar la leche que el bebé dejó de tomar.

ANEXO B.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo.....doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.

He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental o condición, y raza u origen étnico, puedan ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en la que estoy participando.

Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí.

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con

Dentro de los beneficios está la contribución al desarrollo de la investigación, la cual servirá de aporte científico a la mejora continua con resultados que podrán extenderse a ámbitos nacionales.

Nombre completo del participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador

Firma

Fecha